



Atendimento ao Recém-nascido

Sala de parto II

Caso clínico

Histórico materno

Lucinda Pereira de 22 anos, segunda gestação, pré-natal com 10 consultas, sorologias não reagentes para hepatite B e C, VDRL e HIV, toxoplasmose suscetível. Tipagem sanguínea A positivo. Nega intercorrências gestacionais. Idade gestacional de 38 semanas. Nega dados positivos para hábitos e vícios, como também para medicações de uso contínuo. Nega comorbidades.

A gestante procura esta maternidade por dores em baixo ventre há 2 horas e perda de líquido em moderada quantidade há 30 minutos. Após atendimento inicial, é internada para seguimento de trabalho de parto de baixo risco.

Evolução clínica

Recém-nascido de sexo masculino, nasceu de parto vaginal , apresentação cefálica, com hipotonia.

Exame Físico: RN em REG, hipoativo e pouco reativo, hipotônico, hidratado, corado, cianose de extremidades, respiração irregular, afebril. Fontanela anterior normotensa. Fácies atípica.

Pulmões: murmúrio vesicular presente bilateralmente com roncos de transmissão.

Coração: bulhas rítmicas, normofonéticas a 2 tempos, sem sopros.

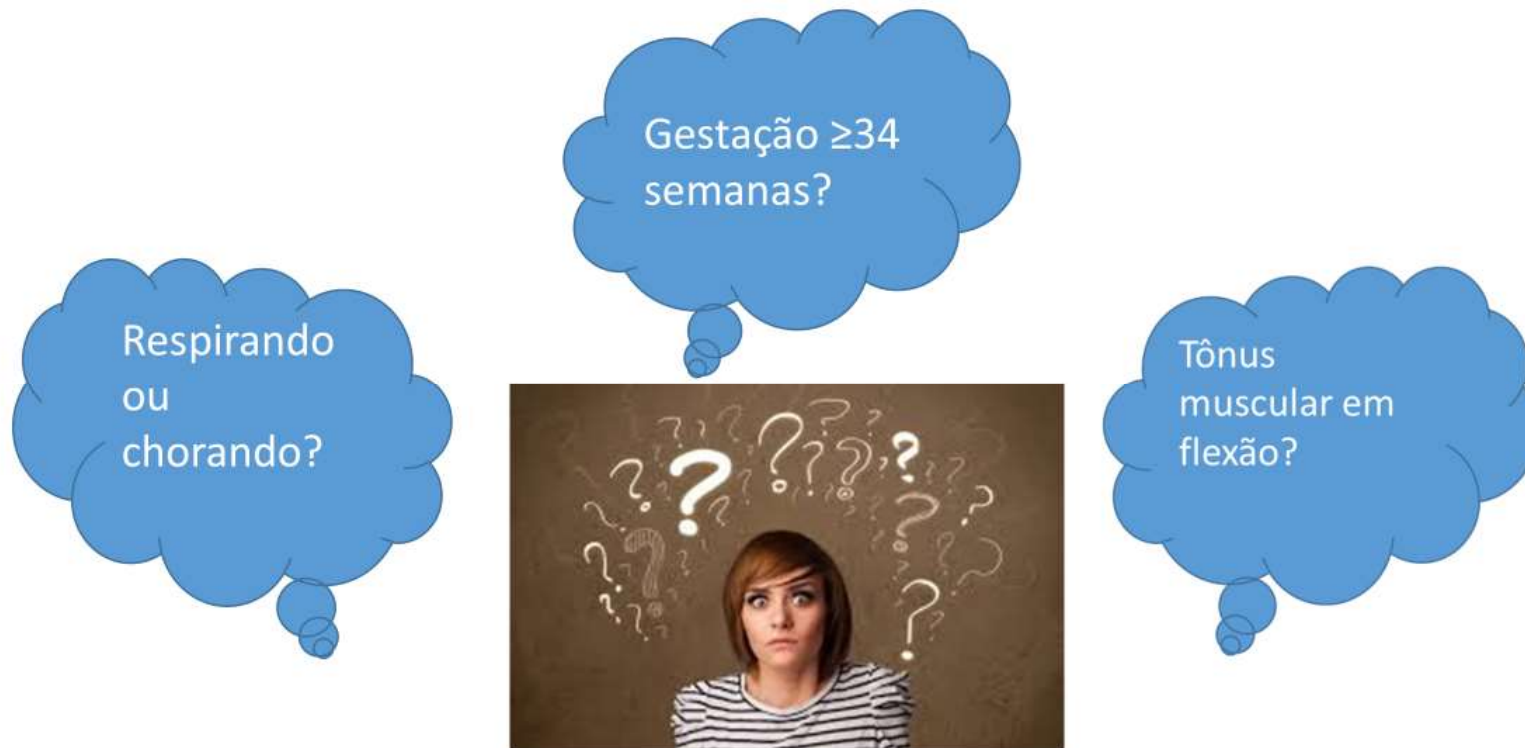
Abdome: globoso, flácido, indolor, sem visceromegalias, indolor.

Presentes. Genitália tipicamente masculina, testículos tópicos. Anus pérvio

Membros: presença de cianose.

Reanimação neonatal

Maiores que 34 semanas



Reanimação neonatal

Avaliação inicial

Respirando
ou chorando?

Gestação ≥ 34
semanas?



Tônus
muscular em
flexão?

O Momento da Decisão: 3 Perguntas Vitais



O Caminho da Intervenção: O Minuto de Ouro

! **Gatilho:** Resposta NÃO para qualquer pergunta (Prematuridade, Apneia/Gasping, Hipotonia).



! **Objetivo:** Reestabelecer a frequência cardíaca e respiração espontânea.

- ! 1. Recepcionar em berço de calor radiante.
- 2. Clampeamento imediato do cordão.



Passos Iniciais (Os Primeiros 30 Segundos)



1. Aquecer

Fonte de calor radiante.



2. Secar

Secar corpo e fontanela. Remover campos úmidos.



3. Posicionar

Leve extensão da cabeça para abrir vias aéreas.



4. Aspirar (Condicional)

Apenas se houver obstrução visível. Não é rotina.

Reavaliação imediata após estes passos.

Avaliação de Vitalidade



Ventilação com Pressão Positiva (VPP)

A ação mais importante da reanimação neonatal.

- Iniciar nos primeiros 60 segundos de vida (Golden Minute).
- Usar ar ambiente (21% O₂) inicialmente para ≥ 34 semanas.
- Instalar monitor cardíaco (3 eletrodos).



Alvos de Saturação de Oxigênio (SatO2 Pré-ductal)



Não suplementar O2 se o bebê estiver dentro destes alvos, mesmo que pareça cianótico.



Falha na Estabilização e Passos Avançados

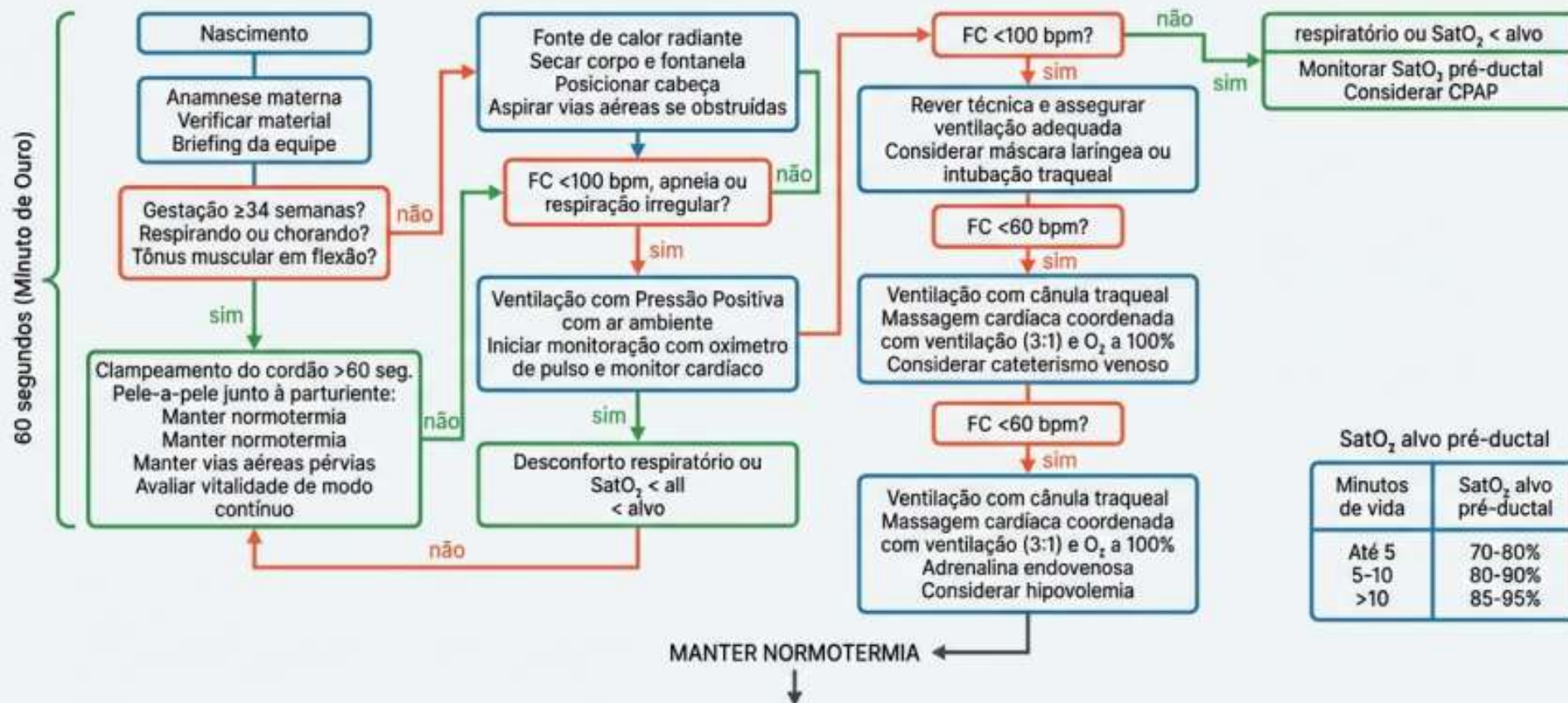
Reavaliação após 30s de VPP. Se FC < 100 bpm:



CHECAR A TÉCNICA

- Ajuste da máscara (vedação).
- Posição da cabeça (vias aéreas).
- Aspiração de secreções.

Resumo: O Algoritmo de Decisão (SBP 2022)



A preparação da equipe e a rapidez na decisão definem o prognóstico.

Conhecimento em Ação Salva Vidas

“O nascimento representa a mais dramática transição fisiológica da vida humana... A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante e efetivo na reanimação ao nascer e, quando necessária, deve ser iniciada nos primeiros 60 segundos de vida ('Minuto de Ouro').”

Para o texto completo das diretrizes, vídeos de treinamento e outros materiais, acesse o portal do Programa de Reanimação Neonatal da SBP.



www.sbp.com.br/reanimacao